Der „Weg“ zur neuen GOÄ

Rahmenbedingungen

Bundesärzteordnung
§ 11: ***Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Entgelte für ärztliche Tätigkeit in einer Gebührenordnung zu regeln.***

Die Bundesregierung

+

Bundesrat

—Verordnung→



Vorlage zur Verordnung

Bundesministerium für Gesundheit

Einigungsgebot:
Verständigung auf einen gemeinsamen Entwurf!

Vorlage zur Prüfung





+ PKV Verband der Privaten Krankenversicherung +



Agenda

- Abstimmung der Leistungslegendierung
- Prozess der Bewertungsfindung
- Änderungsentwürfe BÄO / Paragraphenteil GOÄ

Abstimmung der Leistungslegendierung

Ergebnisse der Verbändegespräche:

Insgesamt **ca. 2600 Änderungsvorschläge** von Berufsverbänden und Fachgesellschaften eingebracht (inkl. Allgemeine Bestimmungen)

⇓

Neues Leistungsverzeichnis mit ca. 5500 Leistungspositionen:

- Komplexierungen wurden überarbeitet, neue Zuschlagssystematik eingeführt

- Zu bereits vorhandenen ca. 900 leistungsbezogenen Erschwerniszuschlägen wurden ca. über **670 weitere Zuschläge zur Abbildung der besonderen Schwere** gefordert (350 primäre und zusätzlich einheitliche Kinderzuschläge etc.)

  ⟹ der Großteil dieser neuen Zuschläge wird vom PKV-Verband akzeptiert

Abstimmung der Leistungslegendierung

Zwischenergebnisse der Legendierungsabstimmung mit PKV-Verband:

- Mehr als die Hälfte der Änderungsvorschläge sind bereits mit PKV-Verband abgestimmt
- Insgesamt werden ungefähr **dreiviertel der eingebrachten Änderungsvorschläge** vom PKV-Verband **akzeptiert**
- Der verbliebene Rest soll in sog. „**trilateralen Gesprächen**“ zwischen den betroffenen Verbänden, dem PKV-Verband und der BÄK abgestimmt werden

16.05.2017

trilateralen Gespräche haben stattgefunden
unsere Vorschläge wurden allesamt akzeptiert
29.8. 17 in Berlin
19.9. 17 in München

Darstellung des Gebührenverzeichnisses

Kapitel	Bezeichnung	Anzahl GOÄ aktuell	Anzahl GOÄ_neu 16.04.2016	neu	obsolet	Anzahl GOÄ_neu aktuell	Differenz
B	Grundleistungen, Allgemeinmedizin	64	71	22	2	91	27
C	Nichtgebietsbezogene Sonderleistungen	177	288	61	9	340	163
D	Anästhesieleistungen, Palliativmedizin und Schmerztherapie	35	61	12	0	73	38
E	Physikalisch medizinische Leistungen	43	50	5	3	52	9
F	Innere Medizin und sonstige nicht-operative Leistungen	144	309	93	13	389	245
G	Neurologische, psychiatrische, psychotherap. psychosom. Leistungen	45	93	63	29	127	82
H	Gynäkologie und Geburtshilfe	107	77	19	0	96	-11
I	Leistungen zur konservativen Augenheilkunde	162	65	2	0	67	-95
J	Leistungen zur konservativen Hals-Nasen-Ohren Heilkunde	153	91	23	4	110	-43
K	Leistungen zur konservativen Urologie	145	18	0	0	18	-127
L	Chirurgie	677	2080	433	75	2438	1761
M	Ärztliche Laboratoriumsleistungen	926	1103	92	0	1195	269
N	Zell- und gewebebasierte Leistungen	15	41	2	0	43	28
O	Leistungen der Strahlendiagnostik, Magnetresonanztomographie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie	214	288	28	4	312	98
P	Sektionsleistungen	9	4	0	0	4	-5
R	Rehabilitationsmedizinische Leistungen		5		0	5	5
	Gesamt	2916	4644	855	139	5360	2444

Differenzierung

Verlagerung operativer Leistungen in L

Differenzierung

Darstellung des Gebührenverzeichnisses

Kapitel	Bezeichnung	Anzahl GOÄ_neu	Anzahl GOÄ aktuell	Differenz
F	Innere Medizin und sonstige nicht-operative Leistungen	389	144	245
	I. Angiologie	26		
	II. Kardiologie	25		
	III. Invasive Kardiologie	76		
	IV. Gastroenterologie	50		
	IX. Endokrinologie/Diabetologie	5		
	V. Nephrologie	23		
	VI. Pneumologie	39		
	VII. Rheumatologie	3		
	VIII. Hämatologie/Onkologie	4		
	X. Arbeitsmedizin	6		
	XI. Kinder- und Jugendmedizin	15		
	XII. Dermatologie	43	Inkl. Lichttherapie: Alt E VII	
	XIII. Konservative Orthopädie	31	Alt L XVI	

Differenzierung

Darstellung des Gebührenverzeichnisses

Kapitel	Bezeichnung	Anzahl GOÄ_neu	Anzahl GOÄ aktuell	Differenz
L	Chirurgie	2438	677	1761

I. Plastische Chirurgie, Oberflächenchirurgie, Replantationschirurgie	231	Neu. Inkl. Wundversorgung/Fremdkörperentfernung
II. Operative Orthopädie und Traumatologie	282	Neu. Inkl. Gelenkchirurgie, Extremitätenchirurgie
III. Arthroskopien	32	Neu
IV. Endoprothetik	162	Neu
IX. HNO Chirurgie	134	Neu. Trennung von operativ und konservativ
V. Neurochirurgie	75	Alt LVIII
VI. Wirbelsäulenchirurgie	97	Neu
VII. Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie	122	Alt L IX
VIII. Halschirurgie	25	Alt L X
X. Thoraxchirurgie	94	Alt L XII
XI. Herzchirurgie	127	Alt L XIII
XII. Gefäßchirurgie	124	Alt L XI
XIII. Operative Gynäkologie	90	Neu. Trennung von operativ und konservativ Gynäkologie / Geburtshilfe
XIV. Operative Urologie	160	Neu. Trennung von operativ und konservativ
XV. Operative Augenheilkunde	112	Neu. Trennung von operativ und konservativ
XVI. Hernienchirurgie	26	Alt L XV
XVII. Viszeralchirurgie	187	Neu. Inkl. Ösophagus- und Abdominalchirurgie

Aktueller Stand zur Änderung der Bundesärzteordnung

Zu den „Empfehlungen" der Gemeinsamen Kommission (GEKO)

Dokument	Inhalt
Bundesärzteordnung	• Besetzung und Aufgaben der GeKo, Rechtsstatus der GeKo-Empfehlungen,

Der 119. DÄT hat beschlossen, dass die GEKO ausschließlich Empfehlungen aussprechen und keine Entscheidungen treffen darf (Beschluss I-05).

Die Adressaten für die Aufgaben der GeKo sind einerseits das BMG und andererseits die abrechnenden Ärztinnen und Ärzte. Für Ärztinnen und Ärzte bedeutet dies, dass sie von den Empfehlungen der GeKo abweichen können und im Streitfalle selbstverständlich den Rechtsweg beschreiten können. Dies gilt vice versa auch für den Patienten bzw. die Versicherer.

Durch die Konstruktion der GeKo hat sich der Verordnungsgeber dazu bekannt, sich mit zwischen der Bundes-ärztekammer, dem PKV-Verband und der Beihilfe konsentierten Empfehlungen auseinanderzusetzen.

Insofern sind die Empfehlungen der GeKo **rechtsprägend**, nicht **rechtsverbindlich** (Gemeinsame Sichtweise der BÄK, des PKV-Verbandes und des BMG.

↳ Stand der Verhandlungen zu BÄO: „Beachten" wurde in „berücksichtigen" geändert.

Aktueller Stand zur Änderung der Bundesärzteordnung

Zur Steigerung des Gebührensatzes

Dokument	Inhalt
Bundesärzteordnung	• Gebührensatz

Der 119. DÄT hat zur Systematik der Steigerung der Gebührenpositionen beschlossen, dass eine ärztliche Honorarrechnung individuell entsprechend dem Aufwand gestaltet werden und hierfür ein Spielraum mit einer freien Wahlmöglichkeit des Faktors in einem gewissen Bereich vorhanden sein muss (Beschluss I - 21).

Die Verhandlungsführer der Bundesärztekammer haben in den Abstimmungsrunden mit PKV und Beihilfe die Möglichkeiten erörtert, die Steigerungsfaktoren weiterhin zu erhalten. Die Verhandlungspartner haben einen Einfachsatz zur conditio sine qua non für die Fortführung der Verhandlungen erklärt. Ein Beharren auf einem individuell einstellbaren Gebührenrahmen ist gleichbedeutend mit dem Ende des Novellierungsprozesses.

↳ Stand der Verhandlungen zu GOÄ: **Zu den 900 vorhandenen Zuschlägen wurden von den Verbänden weitere „Erschwerniszuschläge“ formuliert.**

Der PKV-Verband hat diese überwiegend akzeptiert.

Im Zusammenspiel mit den Erschwernisgründen zur Steigerung auf den 2fachen Satz bilden die Zuschläge die individuell entstehenden Aufwände damit ab.

Aktueller Stand zur Änderung der Bundesärzteordnung

Zur „Negativliste"

Dokument	Inhalt
Bundesärzteordnung	• § 11a Abs. 2) Aufgaben der GeKo (zulässige Behandlungsumstände)
Paragraphenteil GOÄ	• § 2 Negativliste und abweichende Honorarvereinbarungen

Im Workshop mit „übergeordneten" Verbänden und im Ausschuss „Gebührenordnung" wurde die Negativliste kritisch bewertet.

In den Verhandlungen mit dem PKV-Verband wurde die „Negativliste" sowohl aus der Aufgabenbeschreibung der GeKo, als auch aus dem Paragraphenteil ersatzlos gestrichen.

Stand der Verhandlungen zur BÄO:
§ 11a Abs. 2)
Die Gemeinsame Kommission beschließt Empfehlungen, insbesondere [...]
c) zu den zulässigen Behandlungsumständen und dem Umfang der Anwendung des Steigerungssatzes sowie zur Notwendigkeit und Inhalt der Begründung bei Geltendmachung des Steigerungssatzes; ~~dies umfasst auch Behandlungsumstände, bei denen die Anwendung des Steigerungssatzes nicht gerechtfertigt ist.~~

Stand der Verhandlungen zum §§-Teil:
§ 2 GOÄ – Abweichende Vereinbarung
Durch Vereinbarung kann eine von dieser Verordnung abweichende Gebührenhöhe ausschließlich durch Steigerung des nicht unterschreitbaren Gebührensatzes festgelegt werden. Für Leistungen nach § 5a, für Leistungen nach den Abschnitten A, E, M, N und O, ~~sowie anlässlich von Behandlungsumständen, für die Anhang 2 zur Anlage (Negativliste) oder die Gemeinsame Kommission nach §11a BÄO eine Steigerung ausgeschlossen hat~~ ist eine Vereinbarung nach Satz 1 unzulässig.

Aktueller Stand zur Änderung der Bundesärzteordnung

Zur Zuständigkeit der Landesärztekammern

Dokument	Inhalt
Bundesärzteordnung	• Besetzung und Aufgaben der GeKo, Rechtsstatus der GeKo-Empfehlungen,

Umstritten sind auch die mit den Entwürfen zur GOÄ und zur BÄO einhergehenden Eingriffe in Landeskompetenzen. Die berufsrechtliche Beratung ihrer Kammermitglieder zur Anwendung der GOÄ ist Sache der Landesärztekammern.

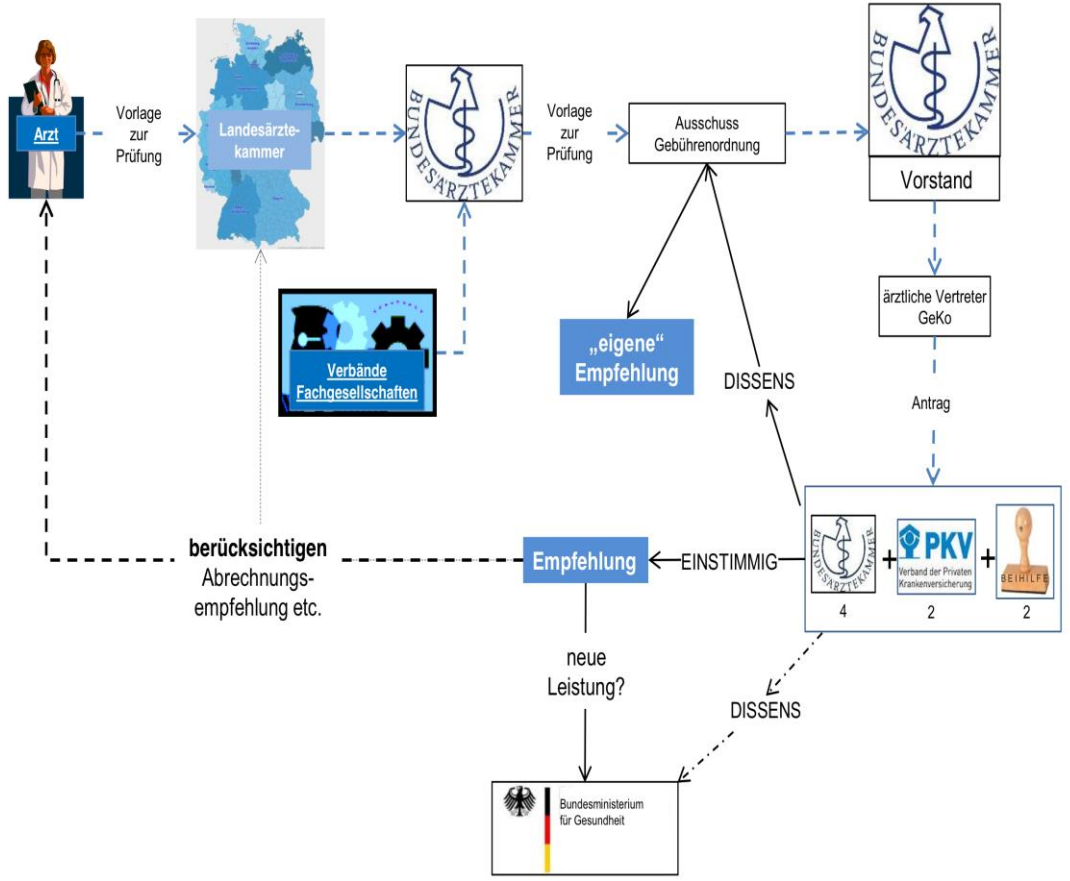
Die Gebührenordnung für Ärzte ist eine Verordnung der Bundesregierung, respektive des Bundesministeriums für Gesundheit. Die Kompetenzen der ärztlichen Selbstverwaltung in diesem Zusammenhang sind aktuell hochgradig eingeschränkt. Die Landesärztekammern können in Auslegungsfragen Positionen einnehmen, die weder für die Bundesregierung noch für die Versicherer bzw. Patienten verbindlich sind. *Die Einrichtung der GeKo eröffnet dagegen der ärztlichen Selbstverwaltung für die Zukunft deutlich größere Gestaltungsspielräume.*

↳ Sowohl die Landesärztekammern als auch die Verbände werden in die Befassung und Ausarbeitung der Empfehlungen der GeKo selbstverständlich eingebunden. Der begonnene Weg zur Einbindung wird weitergeführt. Der Antrag des Vorstandes stellt eindeutig darauf ab!

Das Antragsersuchen des einzelnen Arztes an die GeKo ist gestrichen worden. Es handelt sich primär um die Beurteilung der Angemessenheit einer Gebührenforderung in der Kompetenz der Landesärztekammer.

Der Weg zur Empfehlung in der GeKo

Vorschlag zur Verfahrensweise



Aktueller Stand zur Änderung Paragraphenteils

Dokument	Inhalt
Paragraphenteil GOÄ	• Analogabrechnung

Beschluss I - 17 des 119 DÄT sieht vor die Analogabrechnung wie bisher umzusetzen

In den Verhandlungen wurde die Möglichkeit erörtert die sog. „Stichtagsregelung“ zu streichen, bzw. zu spezifizieren. Im Diskurs mit den Verbänden entsteht eine aktuelle Gebührenordnung auf dem Stand der medizinischen Wissenschaft. Neue Leistungen (= erstmals im Geltungsbereich der GOÄ nach einem - noch festzulegenden - Stichtag angewandt) sollen wie bisher analog berechnet werden können.
„Vergessene“ Leistungen werden von der GeKo schnellstmöglich bearbeitet = Konsens aller Verhandlungspartner.

↳ **Stand der Verhandlungen:** *Selbstständige ärztliche Leistungen, die erst nach dem xx.xx.xxxx erstmals ~~entwickelt und~~ im Geltungsbereich der GOÄ angewandt wurden oder die als Verlangensleistungen erbracht werden, können entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden, solange sie nicht in das Gebührenverzeichnis aufgenommen sind.*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2234	05.05	Diagnostische anorektale Manometrie,	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, Sondeneinführung und Auswertung, je Sitzung		Diagnostische anorektale Manometrie,	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, Sondeneinführung und Auswertung, je Sitzung		BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016
2235	04.02	Anorektale Manometrie,	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, Patiententraining (z. B. Biofeedback) und fortlaufender Kurvendokumentation, je Sitzung		Anorektale Manometrie,	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, Patiententraining (z. B. Biofeedback) und fortlaufender Kurvendokumentation, je Sitzung		BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer in Kapitel E	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016
2236	05.05	Rektoskopie,	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, ggf. einschließlich - Proktoskopie - Analgosedierung - Nachbeobachtung - Pulsoxymetrie oder transkutaner Messung der Sauerstoffsättigung - Probeexzision(en) - Unterspritzung(en) und/oder Probepunktion(en), auch mittels Hochfrequenzdiathermie-Schlinge, je Sitzung		Rektoskopie oder Rektumsaugbiopsie,	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, ggf. einschließlich - Proktoskopie - Analgosedierung - Nachbeobachtung - Pulsoxymetrie oder transkutaner Messung der Sauerstoffsättigung - Probeexzision(en) - Unterspritzung(en) und/oder Probepunktion(en), auch mittels Hochfrequenzdiathermie-Schlinge, je Sitzung		BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer in neu aufzunehmendes Unterkapitel "Proktologie" in Kapitel F, hinter F IV "Gastroenterologie", dies gilt auch für alle	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016
2249	05.05	Proktoskopie	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, ggf. einschließlich - Analgosedierung - Nachbeobachtung - Pulsoxymetrie oder transkutaner Messung der Sauerstoffsättigung - Probeexzision(en) und/oder Probepunktion(en), je Sitzung		Proktoskopie	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, ggf. einschließlich - Analgosedierung - Nachbeobachtung - Pulsoxymetrie oder transkutaner Messung der Sauerstoffsättigung - Probeexzision(en) und/oder Probepunktion(en), je Sitzung		BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer in neu aufzunehmendes Unterkapitel "Proktologie" in Kapitel F,	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016
2250	05.05	Proktologische Untersuchung mit dem Spreizspekulum			Proktologische Untersuchung mit dem Spreizspekulum			BV der Coloproktologen bittet	Verbandsgespräch zur Viszeral- und
2251	05.05	Untersuchung von Analfisteln mit der Sonde,	ggf. einschließlich - mit Instillation und Anfärbung, - rektal digitaler Untersuchung, je Sitzung		Untersuchung von Analfisteln mit der Sonde,	ggf. einschließlich - mit Instillation und Anfärbung, - rektal digitaler Untersuchung, je Sitzung		BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016

8	2252	05.05	Behandlung von Hämorrhoiden durch Sklerosierung mittels Injektion,	ggf. einschließlich rektal-digitaler Untersuchung und/oder Proktoskopie, je Sitzung		Behandlung von Hämorrhoiden durch Sklerosierung mittels Injektion,	ggf. einschließlich rektal-digitaler Untersuchung und/oder Proktoskopie, je Sitzung		BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016
9	2253	05.05	Behandlung von Hämorrhoiden mittels elastischer Ligatur und/oder Entfernen eines Schleimhautvorfalls,	ggf. einschließlich - rektal-digitaler Untersuchung - Proktoskopie, je Sitzung		Behandlung von Hämorrhoiden mittels elastischer Ligatur und/oder Entfernen eines Schleimhautvorfalls,	ggf. einschließlich - rektal-digitaler Untersuchung - Proktoskopie, je Sitzung		BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016
10	2254	05.05	Unblutige Erweiterung des Mastdarmschließmuskels	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, je Sitzung	Die Leistung nach Nummer 2254 ist neben den Leistungen nach den Nummern 2219,	Unblutige Erweiterung des Mastdarmschließmuskels	einschließlich rektal digitaler Untersuchung, je Sitzung	Die Leistung nach Nummer 2254 ist neben den Leistungen nach den Nummern 2219,	BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer in neu aufzunehmendes	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016
11	2255	05.05	Digitale Ausräumung des Mastdarms,	je Sitzung		Digitale Ausräumung des Mastdarms,	je Sitzung		BV der Coloproktologen bittet um Verlegung dieser Ziffer in neu aufzunehmendes Unterkapitel "Proktologie" in Kapitel F, hinter F IV "Gastroenter	Verbandsgespräch zur Viszeral- und Hernienchirurgie am 06.09.2016

6762	Peranale konventionell operative Entfernung einer Mastdarmgeschwulst, ggf. mit Schleimhautnaht,
6763	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 6762 für Vollwand-Resektion, ggf. einschließlich - mikrochirurgisches Vorgehen
9157	Zuschlag zu der Leistung nach den Nummern 6761 oder 6762 für transanale endoskopische mikrochirurgische Abtragung
6861	Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 6761, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768 oder 6784 für die Rekonstruktion des Beckenbodens
6766	Operation eines Afterrisses oder Mastdarmrisses (auch streichen) nach Verletzung,
6767	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 6766 für plastische Rekonstruktion des Rektums
2785	Spaltung bei Perianalvenenthrombose mit Thrombus-Expression(en)besser: Inzision eine
6783	Exzision eines Tumors im Bereich der Analregion, z.B. Fibrom, Thrombose oder Mariske,
6864	Exzision einer Analfissur,
6773	Erweiterung des Mastdarmschließmuskels durch Inzision,
6786	Durchstechungsligaturen von bis zu drei Hämorrhoidalarterien,
6865	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 6786 für Reposition und lokale Raffung der Rektumwand
6787	Operation von Hämorrhoiden durch Hämorrhoidopexie
6788	Hohe intraanale Exzision(en) von bis zu zwei Hämorrhoiden
6774	Exzision eines perianalen Tumors,
6862	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 6774 für plastischen Wundverschluss ohne Muskelplastik
6863	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 6774 für Rekonstruktion mit Muskelplastik
6785	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 6774 für (teilweise) Sakrumresektion,
6784 entfällt?	Operation des Mastdarmvorfalles, z.B. durch peranale Raffung der Rektumwand, kann gestrichen werden
6760	Peranale semizirkuläre Mukosektomie und Muskularisraffung (z.B. nach Sarles)
9154	Peranale zirkuläre Mukosektomie und Muskularisraffung (z.B. nach Rehn-Delorme)
9155	Peranale zirkuläre Rektumsegmentresektion (z.B. nach Mikulicz-Altemeier)
9156	Peranale zirkuläre Rektumwandresektion (z.B. nach STARR-TRANSTARR)
9043	Rekonstruktion des Beckenbodens durch ein- oder beidseitige Levatorplastik,
9044	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 9043 für Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material
9045	Rekonstruktion des Beckenbodens durch post anal repair,
9046	Rekonstruktion des Beckenbodens durch pre anal repair,
9047	Korrektur einer Entero-/Rekto-/Zystozele durch perinealen / peranalen Zugang
9048	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 9047 für Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material

9030	Inzision eines Analabszesses
9031	Exzision eines perianalen Abzesses
9032	Exzision eines ischioanalen Abzesses
9033 neu wo ?	Exzision eines pelvirektalen Abszesses
9034	Exzision einer Akne inversa (perianal oder inguinal)
9035	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 9034 für multilokuläre Exzisionen
9036	Exzision eines Pilonidalsinus
9037	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 9036 für primären lateralen Wundverschluss (z.B. Karydakis,Bascom)
9038	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 9036 für primäre Deckung mit Verschiebelappenplastik
	Nr. 6778-6782 so aus pdf Datei übernommen
6778	Exzision einer subkutanen, submukösen und/oder intersphinktären Analfistel,
6779	Exzision einer transsphinkterischen Analfistel, auch ihres verzweigten Gangsystems,
6780	Exzision einer extrasphinkterischen Analfistel, auch ihres verzweigten Gangsystems
6781	Primäre Rekonstruktion des Sphinkters nach Durchtrennung
6782	Plastische Rekonstruktion des Analkanals mittels Verschiebelappenplastiken, z. B. Mucosa advanc
6777	Verschluss einer Analfistel durch Fistelplugs,
6768	Muskelplastik bei Insuffizienz des Analsphinkters,
6769	Implantation eines künstlichen Analsphinkters,
9150	Explantation eines künstlichen Analsphinkters
6771	Einseitige Gracilisplastik bei Analsphinkterinsuffizenz,
6770	Zuschlag zu der Leistung nach Nummer 6771 für Muskelplastik durch Transfer eines weiteren Muskels (z. B. M. gracilis),
6772	Dynamische Gracilisplastik mit Anlage eines Neurostimulators zur Probestimulation
neu !!	Dynamische Gracilisplastik mit Anlage eines Neurostimulators zur definitiven Implantation des Impulsgebers
9039	Implantation eines temporären Elektrodensystems zur sacralen oder pudendalen Nervenstimulation zur Behandlung der Stuhlinkontinenz
9040	Implantation eines permanenten Elektrodensystems zur sacralen oder pudendalen Nervenstimulation zur Behandlung der Stuhlinkontinenz
9041	Wechsel eines permanenten Impulsgebers zur sacralen Nervenstimulation
9042	Explantation eines permanten Elektrodensystems einschließlich Impulsgeber